

Interpretación del MMPI-2

ESCALAS DE VALIDACIÓN

? (INTERROGANTE)

- ☐ Puntuación Directa: **PD 0 – 1**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Válido.**
 - ☐ Origen de la elevación
 - ☐ Hipótesis interpretativa
-

? (INTERROGANTE)

- ☐ Puntuación Directa: **PD 2 – 10**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Probablemente válido.**
 - ☐ Origen de la elevación
 - ☐ Hipótesis interpretativa
-

? (INTERROGANTE)

- ❑ Puntuación Directa: **PD 11 – 29**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Validez cuestionable.**
 - ❑ Origen de la elevación: **Problemas leves de lectura. Ausencia de experiencia. Supercauteloso o legalista.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Falta de familiaridad con el idioma. Ideación paranoide.**
-

? (INTERROGANTE)

- ☐ Puntuación Directa: **PD $\geq$ 30**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Probablemente inválido.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Serios problemas de lectura o dislexia. Retardo psicomotor. Confusión. Desafío. Indecisión.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Depresión Grave. Estado obsesivo.**
-

L (MENTIRA)

- ☐ Puntuaciones T: **$T < 50$**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Posible actitud de “mala imagen”.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Cuadro de “buscar conseguir algo más”. Todas las respuestas son “verdadero”.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Auto-confiado e independiente. Crítico, sarcástico.**
-

L (MENTIRA)

- ☐ Puntuaciones T: **T 50 – 59**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Válido.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Típica aproximación a los tests. Puntuación dentro de la media.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Conforme con su propia imagen.**
-

L (MENTIRA)

- ❑ Puntuaciones T: **T 60 – 69**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Probablemente válido.**
 - ❑ Origen de la elevación: **Cuadro defensivo.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa:
Superconvencional y conformista.
Moralista. Rígidamente virtuoso.
-

L (MENTIRA)

- ❑ Puntuaciones T: **T 70 - 79**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Probablemente válido.**
 - ❑ Origen de la elevación: **Respuestas al azar. Rechazo de faltas.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Estado de confusión. Estilo represivo. Falta de comprensión.**
-

L (MENTIRA)

- ☐ Puntuaciones T: **$T \geq 80$**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Probablemente inválido.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Fingir un buen ajuste.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Prueba de resistencia o ingenuidad.**
-

F (INCOHERENCIA)

- ☐ Puntuaciones T: **T < 50**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Registro aceptable.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Conformidad.**
Posible falsa imagen.
 - ☐ Hipótesis interpretativa:
Convencionalidad. Sinceridad.
Conformidad.
-

F (INCOHERENCIA)

- ☐ Puntuaciones T: **T 50 – 59**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Registro aceptable.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Puntuaciones dentro de la media.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Buen funcionamiento. Respuestas típicas.**
-

F (INCOHERENCIA)

- ☐ Puntuaciones T: **T 60 – 64**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Probablemente válido.**
 - ☐ Origen de la elevación:
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Problemas en un área particular (trabajo, salud, sexo...).**
-

F (INCOHERENCIA)

- ☐ Puntuaciones T: **T 65 – 79**
 - ☐ Utilidad del perfil: **Probablemente válido.**
 - ☐ Origen de la elevación: **Fingir enfermedad. Procesos psicóticos.**
 - ☐ Hipótesis interpretativa: **Psicótico. Neurótico severo. Problemas de sociabilidad. Propenso a cambios de humor, desasosegado, inquieto, insatisfecho. Cambiante, impredecible.**
-

F (INCOHERENCIA)

- ❑ Puntuaciones T: **T 80 - 100**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Perfil invalidado. Si es válido, considerar serios problemas psicopatológicos.**
 - ❑ Origen de la elevación: **Fingir enfermedad. Procesos psicóticos. Exageración de problemas.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Reafirmación. Deseabilidad social. Estado confusional.**
-

F (INCOHERENCIA)

- ❑ Puntuaciones T: **T > 100**
- ❑ Utilidad del perfil: **Perfil invalidado.**
- ❑ Origen de la elevación: **Respuestas al azar. Errores de corrección. Grave dislexia. Contestar todo como “verdadero”.**
- ❑ Hipótesis interpretativa: **Actitud no cooperativa. Fingir mala imagen de sí mismo. Paciente psiquiátrico que puede estar desorientado, con un comportamiento claramente psicótico.**

K (CORRECCIÓN)

- ❑ Puntuaciones T: **T < 50**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Perfil invalidado**
 - ❑ Origen de la elevación: **Fingir “hacerse el enfermo”. Exageración de los propios desajustes. Contestar a todo como “verdadero”.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Confuso. Autocrítico. Conformista. Introverso. Cínico, suspicaz.**
-

K (CORRECCIÓN)

- ❑ Puntuaciones T: **T 60 - 70**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Validez cuestionada.**
Origen de la elevación: **Defensividad moderada. Negación del problema.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Clínicamente defensivo. Todo lo niega. Intolerante. Sin capacidad para la intuición.**
-

K (CORRECCIÓN)

- ❑ Puntuaciones T: **T > 70**
 - ❑ Utilidad del perfil: **Perfil invalidado.**
Origen de la elevación: **Fingir buena imagen. Marcada defensividad. Contestar a todo como “falso”.**
 - ❑ Hipótesis interpretativa: **Implicación emocional acusada. Inhibición, timidez. Desconfianza. Ausencia de comprensión.**
-

Interpretación del MMPI-2

Escalas Clínicas

ESCALA 1 (Hs) HIPOCONDRIA

- Puntaciones T: $T \geq 80$
 - Hipótesis interpretativas:
 - Relacionado con problemas somáticos graves
 - Ilusiones esquizoides, extrañas ilusiones corporales o somáticas
 - Constreñido, inmovilizado por múltiples síntomas o quejas
-

ESCALA 1 (Hs) HIPOCONDRIA

- Puntaciones T: **T 60 – 80**
- Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Preocupaciones somáticas**
 - ❑ **Reacción exigente a cualquier problema real**
 - ❑ **Exageración de problemas físicos**
 - ❑ **Trastornos del sueño**
 - ❑ **Falta de energía**
 - ❑ **Exigente**
 - ❑ **Insatisfecho**
 - ❑ **Quejas variables y múltiples**

ESCALA 1 (Hs) HIPOCONDRIA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Pequeñas preocupaciones, o ninguna, acerca del cuerpo o de la salud**
 - **Emocionalmente abierto y equilibrado**
 - **Realista y perspicaz**
-

ESCALA 1 (Hs) HIPOCONDRIA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Ausencia de preocupaciones somáticas**
 - **Enérgico**
 - **Optimista**
 - **Intuitivo**
 - **Capaz, efectivo**
-

ESCALA 2 (D) DEPRESIÓN

- Puntaciones T: $T \geq 70$
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ Depresión clínica severa
 - ❑ Reservado, afectado seriamente por los problemas, desesperado
 - ❑ Culpabilizado, con sentimientos de inutilidad e inadecuación
 - ❑ Preocupado por la muerte, suicida
 - ❑ Abatido, lento en el pensar y en el actuar
-

ESCALA 2 (D) DEPRESIÓN

- Puntaciones T: **T 60 – 70**
- Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Depresión moderada**
 - ❑ **Insatisfecho con la vida**
 - ❑ **Preocupado, ausencia de energía, incapacidad de concentración**
 - ❑ **Quejas somáticas, problemas de sueño**
 - ❑ **Reservado**
 - ❑ **Falta de confianza en sí mismo, auto-depreciación, molesto, miserable**
- ❑ **Disfórico**

ESCALA 2 (D) DEPRESIÓN

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Conforme consigo mismo**
 - **Estable, ajustado, realista**
-

ESCALA 2 (D) DEPRESIÓN

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Alegre, de buen humor**
 - ❑ **Seguro de sí mismo, autoconfiado**
 - ❑ **Ausencia de inhibición, impulsivo, a veces descontrolado**
 - ❑ **Socialmente extravertido**
 - ❑ **Ausencia de desórdenes emocionales**
-

ESCALA 3 (Hy) HISTERIA

- Puntaciones T: $T \geq 80$
 - Hipótesis interpretativas:
 - Considerar Reacción de conversión
 - Elevada sugestionabilidad
 - Frecuente ansiedad y episodios de pánico
 - Desinhibido
 - Rabietas infantiles
 - Reacciona a la vergüenza desarrollando síntomas físicos
-

ESCALA 3 (Hy) HISTERIA

- Puntaciones T: **T 60 – 80**
- Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Síntomas somáticos**
 - ❑ **Trastornos del sueño**
 - ❑ **Ausencia de comprensión acerca de las causas de los síntomas**
 - ❑ **Negatividad**
 - ❑ **Inmadurez, centrado en sí mismo**
 - ❑ **Exigente, absorbente**
 - ❑ **Sugestionable**
 - ❑ **Cariñoso**

ESCALA 3 (Hy) HISTERIA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Realista, abierto a los sentimientos**
 - **Lógico, sensato**
-

ESCALA 3 (Hy) HISTERIA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Reservado, conformista, convencional**
 - **Intereses reducidos**
 - **Socialmente aislado y reservado**
 - **Crítico, de mente cerrada**
-

ESCALA 4 (Pd) DESVIACIÓN PSICOPÁTICA

- Puntaciones T: **$T \geq 75$**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Asocial/ comportamiento antisocial**
 - ❑ **Juicio pobre**
 - ❑ **Inestabilidad**
 - ❑ **Irresponsable**
 - ❑ **Egocentrismo, inmadurez**
 - ❑ **Atacante y agresivo**
-

ESCALA 4 (Pd) DESVIACIÓN PSICOPÁTICA

- Puntaciones T: **T 60 – 75**
- Hipótesis interpretativas:
 - ❑ Puede tener problemas con la ley y la autoridad (varones)
 - ❑ Puede consumir drogas no autorizadas (varones)
 - ❑ Problemas familiares
 - ❑ Impulsividad
 - ❑ Airada, irritable, no cooperativa (mujeres)
 - ❑ Culpabilidad, vergüenza
 - ❑ Extroversión
 - ❑ Relaciones superficiales
 - ❑ Enérgico
- ❑ Creativo

ESCALA 4 (Pd) DESVIACIÓN PSICOPÁTICA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Sincero, confiado**
 - **Responsable, persistente**
-

ESCALA 4 (Pd) DESVIACIÓN PSICOPÁTICA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Convencional y rígido**
 - ❑ **Aceptación de la autoridad**
 - ❑ **Sincero**
 - ❑ **Persona de confianza**
 - ❑ **Moralista, autocrítico**
 - ❑ **Excesivamente cumplidor**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: VARONES

- Puntaciones T: $T \geq 75$
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Considerar graves problemas sexuales**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: VARONES

- **Puntaciones T: T 60 – 75**
 - **Hipótesis interpretativas:**
 - **Conflictos sobre la identidad sexual**
 - **Afeminado**
 - **Ausencia de intereses masculinos tradicionales**
 - **Intereses intelectuales**
 - **Sensible, empático**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: VARONES

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Práctico**
 - **Acomodaticio**
 - **Realista**
 - **Convencional**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: VARONES

- **Puntuaciones T: $T < 40$**
 - **Hipótesis interpretativas:**
 - ❑ **Patrón tradicional de intereses masculinos**
 - ❑ **Declaraciones machistas, crudo, agresivo**
 - ❑ **Intereses reducidos, escasos**
 - ❑ **No le gusta jugar con los sentimientos**
 - ❑ **Imprudente**
 - ❑ **Orientado a la acción**
 - ❑ **Autoconfiado**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: MUJERES

- Puntaciones T: $T \geq 75$
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Considerar graves problemas sexuales**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: MUJERES

- Puntaciones T: **T 60 – 75**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Rechazo del papel tradicional femenino**
 - **Asertiva**
 - **Segura de sí misma**
 - **Competitiva**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: MUJERES

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Empática**
 - **Capaz**
 - **Competente**
 - **Acomodaticia**
 - **Considerada**
 - **Idealista**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: MUJERES

- Puntaciones T: **$T < 40$**
 - Hipótesis interpretativas en el caso de bajo nivel cultural:
 - **Se presenta a sí misma como muy femenina**
 - **Pasiva, sumisa, complaciente, dócil**
 - **Quejica**
 - **Ingenua, idealista**
-

ESCALA 5 (Mf) MASCULINIDAD-FEMINIDAD: MUJERES

- Puntaciones T: **$T < 40$**
 - Hipótesis interpretativas en el caso de buen nivel cultural:
 - ❑ **No especialmente femenina a la manera tradicional**
 - ❑ **Capaz, segura, concienzuda**
 - ❑ **Enérgica, competitiva**
 - ❑ **Considerada**
 - ❑ **Flexible, informal**
-

ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **$T \geq 70$**
- Hipótesis interpretativas:
 - **Considerar psicosis paranoide**



ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **T 60 – 70**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Predisposición paranoide**
 - ❑ **Excesivamente sensible**
 - ❑ **Suspicaaz**
 - ❑ **Airado, resentido**
 - ❑ **Reservado**
-

ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **T 50 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Sensible**
 - **Suspicaaz**
 - **Airado, resentido**
 - **Ausencia de control emocional**
-

ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **T 45 – 49**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Racional**
 - **Pensamiento claro**
 - **Cauto**
 - **Flexible**
-

ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **T 35 – 44**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Tenaz**
 - **Evasivo**
 - **Egocéntrico**
 - **Insatisfecho**
 - **Sin intuición**
 - **Considerar psicosis**
-

ESCALA 6 (Pa) PARANOIA

- Puntaciones T: **T < 35**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Probablemente psicosis paranoide**
 - **Cauteloso y evasivo**
 - **Testarudo**
-

ESCALA 7 (P_t) PSICASTENIA

- Puntaciones T: **$T \geq 75$**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Miedo extremo, ansiedad, tensión**
 - ❑ **Trastornos del pensamiento**
 - ❑ **Percepción defectuosa**
 - ❑ **Falta de concentración**
 - ❑ **Rumiaciones**
 - ❑ **Rituales rígidos**
 - ❑ **Fobias supersticiosas**
 - ❑ **Sentimientos de culpa**
-

ESCALA 7 (P_t) PSICASTENIA

- Puntaciones T: **T 60 – 75**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Ansiedad, moderada depresión**
 - ❑ **Pesadillas en los sueños**
 - ❑ **Falta de seguridad en sí mismo**
 - ❑ **Culpabilidad**
 - ❑ **Perfeccionista**
 - ❑ **Indecisión**
 - ❑ **No se siente aceptado por los demás**
-

ESCALA 7 (Pt) PSICASTENIA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Confiable**
 - **Sincero**
 - **Adaptable**
 - **Bien organizado**
-

ESCALA 7 (P_t) PSICASTENIA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Ausencia de desórdenes emocionales**
 - ❑ **Seguridad en sí mismo**
 - ❑ **Capaz, competente**
 - ❑ **Personalidad con prestigio, éxito, reconocimiento**
-

ESCALA 8 (Sc) ESQUIZOFRENIA

- Puntaciones T: **$T \geq 75$**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Posible trastorno esquizofrénico**
-

ESCALA 8 (Sc) ESQUIZOFRENIA

- Puntaciones T: **T 60 – 75**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Esquizoide**
 - ❑ **Confuso**
 - ❑ **Miedoso**
 - ❑ **Pesadillas en los sueños**
 - ❑ **Reservado, no comprometido**
 - ❑ **Fantasías y ensueños excesivos**
-

ESCALA 8 (Sc) ESQUIZOFRENIA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Adaptable**
 - **Dependiente**
 - **Buen equilibrio**
-

ESCALA 8 (Sc) ESQUIZOFRENIA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Sensible**
 - ❑ **Confiado**
 - ❑ **Prudente, convencional**
 - ❑ **Concreto, práctico**
 - ❑ **Condescendiente, sumiso**
-

ESCALA 9 (Ma) HIPOMANÍA

- Puntaciones T: **$T \geq 80$**
- Hipótesis interpretativas:
 - **Posible trastorno bipolar, tipo maníaco**



ESCALA 9 (Ma) HIPOMANÍA

- Puntaciones T: **T 70 – 80**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Energía excesiva**
 - ❑ **Ausencia de dirección**
 - ❑ **Desorganización conceptual**
 - ❑ **Poco realista en su auto-valoración**
 - ❑ **Tiránico, mandón**
 - ❑ **Muy hablador**
 - ❑ **Baja tolerancia a la frustración**
 - ❑ **Impulsivo**
-

ESCALA 9 (Ma) HIPOMANÍA

- Puntaciones T: **T 60 – 69**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Activo**
 - **Enérgico**
 - **Extrovertido**
 - **Creativo**
 - **Rebelde**
-

ESCALA 9 (Ma) HIPOMANÍA

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Sociable y amistoso**
 - **Responsable**
 - **Realista**
 - **Entusiasta**
 - **Equilibrado**
-

ESCALA 9 (Ma) HIPOMANÍA

- Puntaciones T: **T < 40**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Sensible**
 - **Confiado**
 - **Responsable**
 - **Prudente, convencional**
 - **Sumiso, condescendiente**
 - **Práctico, concreto**
-

ESCALA 0 (Si) INTROVERSIÓN SOCIAL

- Puntaciones T: $T \geq 75$
- Hipótesis interpretativas:
 - **Extremadamente reservado**

ESCALA 0 (Si) INTROVERSIÓN SOCIAL

- Puntaciones T: **T 60 – 75**
- Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Introverso, reservado, tímido**
 - ❑ **Depresivo, culpable**
 - ❑ **Bajo ritmo personal**
 - ❑ **Ausencia de seguridad en sí mismo**
 - ❑ **Ausencia de intereses**
 - ❑ **Supercontrolado**
 - ❑ **Sumiso, condescendiente**
 - ❑ **Persona de confianza, formal**
 - ❑ **Responsable en el trabajo**

ESCALA 0 (Si) INTROVERSIÓN SOCIAL

- Puntaciones T: **T 40 – 59**
 - Hipótesis interpretativas:
 - **Puntuaciones medias**
 - **Activo, energético**
 - **Amistoso**
 - **Equilibrado**
 - **Hablador**
-

ESCALA 0 (Si) INTROVERSIÓN SOCIAL

- Puntaciones T: **$T < 40$**
 - Hipótesis interpretativas:
 - ❑ **Extravertido, sociable**
 - ❑ **Seguro de sí mismo**
 - ❑ **Enérgico**
 - ❑ **Competitivo**
 - ❑ **Poco controlado**
 - ❑ **Manipulador**
-

Interpretación del MMPI-II

Escalas de contenido

ANX Ansiedad

(Implicación de puntuaciones altas)

- Síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, problemas somáticos (tales como problemas cardíacos y respiración entrecortada), problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración.
- Los sujetos temen perder el juicio, viven en tensión y tienen dificultades para tomar decisiones.

ANX Ansiedad

(Implicación de puntuaciones altas)

- Parecen conscientes de estos síntomas y problemas y admiten libremente que los tienen.

FRS Miedos

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujeto con muchos temores específicos (a ver sangre, a lugares altos, relacionados con el dinero, a los animales -serpientes, ratones o arañas-, a salir de casa, al fuego, tormentas, desastres naturales, al agua, oscuridad, a lugares cerrados o a la suciedad).

OBS Obsesividad

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos con grandes dificultades para tomar decisiones y propensos a rumiar excesivamente sus problemas.
- Les molesta tener que hacer cambios y tienen algunas conductas compulsivas (contar o coleccionar cosas sin importancia).
- Excesivamente preocupados, frecuentemente asfixiados por sus propios pensamientos.

DEP Depresión

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos con pensamientos significativamente depresivos, melancólicos, sin interés por su vida y con incertidumbre acerca de su futuro.
- Dan muchas vueltas a las cosas, están tristes, desesperanzados y lloran fácilmente.
- No suelen ver a los demás como fuente de ayuda.

HEA Preocupaciones por la salud

(Implicación de puntuaciones altas)

- Presentan muchos síntomas físicos gastrointestinales -náuseas, vómitos-, neurológicos, sensoriales, cardiovasculares, dermatológicos y dificultades respiratorias.
- Se preocupan por su salud y enferman más que el promedio de las personas.

BIZ Pensamiento extravagante

(Implicación de puntuaciones altas)

- Indica procesos de pensamiento psicótico.
- Informa de alucinaciones auditivas, visuales u olfativas.
- Pueden informar de ideación paranoide.
- Estos individuos pueden sentir que tienen una misión especial o que poseen poderes especiales.

ANG Hostilidad

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sugiere dificultades con el control de la ira. Sujetos irritables, gruñones, impacientes, exaltados, molestos y tercos.
- Pueden perder el control sobre sí mismos y dicen haber abusado físicamente de personas y objetos.

CYN Cinismo

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos que esperan ocultas motivaciones negativas tras los actos de los demás.
- Desconfían de los demás porque creen que la gente usa a los otros y establece amistades sólo por razones egoistas.
- Tienden a tomar actitudes negativas hacia las personas cercanas a ellos - amigos, familiares y compañeros-.

ASP Conductas antisociales

(Implicación de puntuaciones altas)

- Informan de conductas problemáticas durante la escolarización y otras como robos, estafas, ...
- Disfrutan con las fechorías de los criminales incluso creen que es correcto bordear los límites de la ley, si es que no tienen expresamente un comportamiento fuera de la misma.

TPA Comportamiento tipo A

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos que trabajan duramente, orientados al trabajo y que se mueven rápidamente.
- Frecuentemente se irritan, impacientan y se molestan. No les gusta esperar ni ser interrumpidos. Para ellos el día no tiene suficientes horas.
- En sus relaciones con los demás son directos y autoritarios.

LSE Baja autoestima

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos que tienen una mala opinión de sí mismos. No creen que los demás les aprecien ni les crean importantes.
- Adoptan múltiples actitudes negativas hacia sí mismos -se consideran torpes, inútiles, nada atractivos y una carga para los demás-.
- Les cuesta aceptar cumplidos y se ven abrumados por los errores que se ven.

SOD Malestar social

(Implicación de puntuaciones altas)

- Se sienten intranquilos cuando están rodeados de gente y prefieren estar solos. Les gusta sentarse solos en vez de hacerlo con el grupo.
- Se consideran tímidos, no les gustan los actos sociales ni las fiestas.

FAM Problemas familiares

(Implicación de puntuaciones altas)

- Sujetos que informan de considerables discordias familiares. Sus familias son descritas como carentes de amor.
- Pueden incluso sentir odio hacia miembros de su familia.
- Su infancia puede describirse como humillante y sus matrimonios como infelices y carentes de afecto.

WRK Interferencia laboral

(Implicación de puntuaciones altas)

- Conductas o actitudes que probablemente contribuyen a una deficiente ejecución en el trabajo.
- Algunos problemas se relacionan con baja autoestima, dificultades de concentración, obsesividad o tensión.
- Otros sugieren

TRT Indicadores negativos de tratamiento

- Actitudes negativas hacia los médicos y hacia el tratamiento en salud mental. No se sienten cómodos discutiendo sus problemas con otros.
- Creen que nadie puede atenderles o ayudarles. Pueden no querer cambiar nada de sus vidas, ni creen que sea posible el cambio. Prefieren darse por vencidos frente a las dificultades.

Interpretación del MMPI-2

Correlatos de tipos de códigos

1-2/2-1

- Presentan problemas somáticos y dolor, quejas, preocupaciones por la salud.
- Reaccionan de manera extrema ante disfunciones físicas menores.
- Informan de fatiga, mareos, , pero se resisten a las interpretaciones psicológicas de sus síntomas.
- Cohibidos, introvertidos y tímidos.

1-3/3-1

- Pacientes con un diagnóstico de trastorno psicofisiológico o neurótico (histérico, hipocondríaco). En general están ausentes la ansiedad y depresión graves.
- Buscan atención. Abiertos y extrovertidos. Convencionales y conformistas.
- Tienden a negar y racionalizar su conducta. Motivación para la terapia.

1-4/4-1

- Síndromes hipocondríacos graves.
- Indecisos, ansiosos, extrovertidos, insatisfechos, pesimistas, irascibles, agresivos, carecen de HH para relacionarse con el sexo opuesto.
- Rebeldía hacia el hogar y los padres, pero no lo expresan. Carecen de “empuje”.
- Pueden utilizar el alcohol en exceso.
- Mala disposición a la psicoterapia.

1-8/8-1

- Sentimientos de hostilidad y agresión, sin poderlos expresar de manera adaptativa.
- Inhibidos y reprimidos o beligerantes y puntillosos. Socialmente inadecuados, no confían en los demás.
- Estilo de vida aislado, se sienten infelices y deprimidos.
- Aplanamiento afectivo, se sienten confundidos y distraídos.

1-9/9-1

- Está presente la angustia extrema. Ansiedad, tensión e inquietud.
- Agresivos y beligerantes aunque son pasivo-dependientes aunque intentan negarlo.
- Ambiciosos, con un alto nivel de “empuje”, aunque carecen de metas claras, lo cual hace que se sientan frustrados.

2-3/3-2

- Se sienten nerviosos, tensos, preocupados, tristes y deprimidos, aunque no experimentan una ansiedad que los incapacite. Tienden a poseer un control exagerado. Niegan los impulsos indeseables.
- Son pasivos, dóciles e dependientes y provocan en los demás el deseo de cuidarlos. No responden a la psicoterapia.
- Inadaptación sexual –frigidez e impotencia-. Incómodos ante el sexo opuesto.

2-4/4-2

- Pueden tener antecedentes por problemas legales. Impulsivos, con poco respeto a las normas y valores sociales. *Acting out*.
- Pueden expresar culpa y remordimiento pero no son sinceros. Aunque aparentan ser sociables a corto plazo, crean resentimiento en los demás.
- Riesgo de suicidio.
- Dificultades para la psicoterapia.

2-7/7-2

- Presentan generalmente síntomas asociados con el estado de ánimo –depresión, ansiedad, tensión-. Reaccionan en extremo ante el menor estrés. Informan de una variedad de problemas físicos y se sienten tristes e infelices.
- Escrupulosos, con altas expectativas y poco realistas respecto a ellos mismos.
- Buen pronóstico en psicoterapia.

2-8/8-2

- Parecen ansiosos, agitados tensos e intranquilos. Tienen trastornos de sueño e incapacidad para concentrarse. Son olvidadizos y tienen pensamiento confuso. Son ineficaces para cumplir sus responsabilidades.
- Sus rasgos de personalidad incluyen dependencia, falta de asertividad, irritabilidad y resentimiento. Sienten una pérdida de control y no expresan sus emociones.

2-9/9-2

- Es probable que estos pacientes sean egoístas y narcicistas, meditan en exceso acerca de su propia valía.
- Pueden ser ansiosos. Con frecuencia niegan sus sentimientos de incapacidad y falta de valía, defendiéndose de la depresión a través de actividad excesiva.
- El diagnóstico más común es el de trastorno maníaco-depresivo.

3-4/4-3

- Estos pacientes albergan impulsos hostiles y agresivos, pero no pueden expresarlos de manera apropiada. En general tienen un control extremo, aunque aparecen episodios breves de *acting out* violento.
- Muestran sentimientos profundos y crónicos de hostilidad hacia los miembros de la familia, demandan atención y aprobación de los demás, no obstante son sensibles al rechazo.

3-6/6-3

- Presentan tensión y ansiedad. Muestran sentimientos de hostilidad hacia los miembros de su familia. No expresan de manera directa sus sentimientos negativos.
- A menudo son insolentes, poco cooperativos y difíciles de tratar. Refieren tener resentimiento y son egocéntricos y narcicistas. Niegan tener problemas psicológicos y poseen una actitud cándida y crédula hacia el mundo.

3-8/8-3

- Muestran agitación psicológica intensa. Parecen ansiosos, temerosos y preocupados, tienen fobias, depresión, sentimientos de desesperanza.
- Es probable que sean inmaduros, dependientes y que tengan una fuerte necesidad de atención y afecto. Son intrapunitivos, apáticos y pesimistas.
- Pueden presentar trastornos del pensamiento, problemas de concentración, ...

4-5/5-4

- Muestran agitación psicológica intensa. Parecen ansiosos, temerosos y preocupados, tienen fobias, depresión, sentimientos de desesperanza.
- Es probable que sean inmaduros, dependientes y que tengan una fuerte necesidad de atención y afecto. Son intrapunitivos, apáticos y pesimistas.
- Pueden presentar trastornos del pensamiento, problemas de concentración, ...

4-6/6-4

- Son inmaduros, narcicistas, indulgentes consigo mismos y pasivo-dependientes. A menudo hacen demandas en búsqueda de atención, simpatía y compasión, pero se resienten por las demandas que se les hacen. No se llevan bien con los demás, especialmente con el sexo opuesto.
- Son irritables, malhumorados, fastidiosos , discuten mucho y se revelan a la autoridad.

4-7/7-4

- Pueden alternar entre periodos de gran insensibilidad acerca de las consecuencias de sus actos y la preocupación excesiva por los efectos de su conducta. Con frecuencia tienen episodios de *acting out*, seguidos de culpa y autocensura.
- Quejas somáticas vagas, tensión, fatiga, agotamiento, dependencia e inseguridad. Requieren constantemente que se reafirme su propia valía.

4-8/8-4

- Parecen no encajar en su ambiente, parecen extraños y peculiares, son poco conformistas y resentidos con la autoridad. Pueden adherirse a puntos de vistas radicales en religión o política. Tienen problemas con el control de impulsos.
- Manifiestan profundos sentimientos de inseguridad, teniendo la necesidad exagerada de atención y afecto. Presentan un autoconcepto pobre y se predestinan al fracaso.

4-9/9-4

- Pueden mostrar una notable desconsideración hacia las normas y valores sociales. Tienen un pobre desarrollo de la conciencia y unos valores éticos inestables. Problemas legales o laborales. Acoholismo, disputas y *acting out sexual*.
- Narcicistas, egoístas, impulsivos e indulgentes consigo mismos. No desean aprender de las experiencias de castigo. Racionalizan los defectos y culpan a los demás de sus fallos.

6-8/8-6

- Pensamiento autista y delirante, con contenido bizarro. Dificultad para concentrarse, atender y memorizar. Poseen una capacidad de juicio deficiente y sentimientos irreales. Embotamiento afectivo. Pueden tener un discurso rápido e incoherente. Carecen de mecanismos de defensa eficaces y pueden mostrar ansiedad extrema.
- Tienen dificultad para diferenciar entre la fantasía y la realidad.

6-9/9-6

- Muy sensibles y desconfiados. Muestran una fuerte necesidad de afecto y manifiestan ansiedad la mayor parte del tiempo. Lloran fácilmente y reaccionan de manera extrema ante el menor estrés. No pueden expresar sus emociones de manera adaptativa.
- Parecen desorientados y confundidos, además de tener una capacidad de juicio deficiente.

7-8/8-7

- Muestran una gran agitación y confusión y no dudan en admitir que tienen problemas psicológicos.
- Se sienten deprimidos, preocupados y nerviosos. Pueden presentar estados de pánico. Son introspectivos y ensimismados.
- Presentan sentimientos crónicos de inseguridad, incapacidad, inferioridad e indecisión. Carecen de experiencias de socialización.

8-9/9-8

- Egocéntricos e infantiles en sus expectativas de los demás, demandan gran cantidad de atención, volviéndose resentidos y hostiles cuando no se satisfacen sus demandas. Temen a los compromisos emocionales y evitan las relaciones estrechas. Muestran tendencia a una adaptación sexual deficiente.
- Demuestran un discurso fuerte y excesivo y una estimación poco realista de sí mismos.